Árbol de decisión — Cadera

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Cadera. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b.

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 3 si «SÍ» o «SÍ, con chasquido doloroso, bloqueo o fallo»

3b ¿Thomas positivo con historia compatible (signo de la «C», síntomas mecánicos)? Identificar la entidad; pueden coexistir.
📝 G8 · R1, R2, R3

- INESTABILIDAD / LIGAMENTO REDONDO → 12 Ligamento Redondo e Inestabilidad
- CONDROPATÍA → 13 Condropatía de Cadera
- ARTROSIS → 1 Artrosis de Cadera
- FAIS / LABRUM → sin hipótesis
- NO CONCLUYENTE → sin hipótesis

Sí / Sí, con chasquido doloroso, bloqueo o fallo

1 ¿El dolor podría ser referido desde la columna lumbar o la articulación sacroilíaca?

todas

1b ¿Hay un evento desencadenante concreto y reciente (chut, sprint, cambio de dirección, estiramiento)?
📝 G2, G3 · R7

todas

2 ¿El perfil es degenerativo (edad ≥45 años, rigidez matutina breve)? 📝 R1, R2

todas

3 ¿Sospecha de origen intraarticular: dolor inguinal ligado al movimiento con FADDIR o flexión-RI positivos? Estos tests descartan; positivos no confirman. 📝 R1, R2

Respuestas

- **SÍ** — SACROILÍACA: señala con el dedo el dolor inferomedial a la EIPS (no solo en la línea media ni por encima de L5) y 3 o más de 5 tests de provocación positivos → 10 Dolor Articular Sacroilíaco
- **SÍ** — LUMBAR: el dolor cambia con movimientos repetidos de la espalda, o la elevación de la pierna recta o el slump reproducen su dolor → sin hipótesis
- **NO** — Origen coxofemoral: la cojera (unas 7 veces) y la rotación interna limitada (unas 14 veces) orientan más a la cadera que a la columna → sin hipótesis

Respuestas

- **SÍ** — LESIÓN AGUDA: palpar primero; luego resistencia y estiramiento → 11 Lesión Aguda de Ingle
- **NO** — Sin evento desencadenante concreto → sin hipótesis

Respuestas

- **SÍ** — Edad ≥45 años, rigidez matutina <1 hora, rotación interna <24° → 1 Artrosis de Cadera
- **NO** — Paciente joven/activo con síntomas mecánicos → sin hipótesis

Respuestas

- **SÍ** — Compatible con pinzamiento femoroacetabular (SIFA), sin confirmar: seguir con Thomas → 2 Síndrome de Pinzamiento Femoroacetabular (SIFA) → desvío 3b
- **SÍ, con chasquido doloroso, bloqueo o fallo** — Posible desgarro labral → 2 Síndrome de Pinzamiento Femoroacetabular (SIFA) + 3 Desgarro del Labrum Acetabular → desvío 3b
- **NO** — FADDIR y flexión-RI negativos: origen intraarticular improbable → sin hipótesis
- **NO EXPLORADO** — FADDIR y flexión-RI no realizados (contraindicados o no tolerados): origen intraarticular sin valorar → sin hipótesis

continúa en la página siguiente →

4 ¿El dolor se localiza en la CARA EXTERNA de la cadera (trocánter mayor)? 📝 R1

todas

5 ¿El dolor se localiza en el GLÚTEO o zona isquiática?

todas

6 ¿Qué reproduce su dolor conocido en la INGLE? Palpar primero y con precisión: las estructuras se solapan.

📝 R1, R4, R5, R6, R8

todas

7 ¿Hay un patrón neuropático, o nada encaja y el dolor es extenso? 📝 R2

Respuestas

- **SÍ** — Sensibilidad en trocánter mayor y dolor en apoyo monopodal <30s → **4 Síndrome de Dolor Trocantérico Mayor (Tendinopatía Glútea)**
- **SÍ** — Con marcha de Trendelenburg o debilidad medida en abductores → **5 Debilidad de Abductores de Cadera**
- **SÍ** — Calidad deficiente en sentadilla monopodal o step-down → **6 Disfunción de Control Neuromuscular de Cadera**
- **NO** — Sin dolor lateral → sin hipótesis

Respuestas

- **Dolor profundo en glúteo que empeora al sentarse (ciática)** — posible Síndrome Piriforme → **7 Síndrome Glúteo Profundo (Síndrome Piriforme)**
- **Dolor que empeora con zancada larga al caminar** — posible Pinzamiento Isquiofemoral → **8 Pinzamiento Isquiofemoral**
- **Sensibilidad sobre tuberosidad isquiática** — posible Tendinopatía Proximal Isquiotibiales → **9 Tendinopatía Proximal de Isquiotibiales**
- **Sin localización clara posterior** → sin hipótesis

Respuestas

- **ADUCTOR** — Palpación dolorosa de aductores + squeeze doloroso → **16 Dolor Inguinal Relacionado con el Aductor**
- **PSOAS ILÍACO** — Palpación dolorosa supra o infrainguinal → **17 Dolor Inguinal Relacionado con el Psoas Ilíaco**
- **INGUINAL** — Palpación dolorosa del canal sin hernia palpable (de pie y con tos) → **18 Dolor Inguinal Relacionado con el Canal Inguinal**
- **PÚBICO** — Palpación dolorosa de la sínfisis y el hueso adyacente → **19 Dolor Inguinal Relacionado con el Pubis**
- **NINGUNO** — Sin dolor inguinal o nada lo reproduce → sin hipótesis

Respuestas

- **MERALGIA** — Tinel bajo la EIAS, parestesias anterolaterales del muslo → **14 Neuropatías de Cadera e Ingle**
- **OBTURADOR** — Dolor en ingle y muslo medial con el ejercicio → **14 Neuropatías de Cadera e Ingle**
- **ILIOINGUINAL, ILIOHIPOGÁSTRICO O GENITOFEMORAL** — Arch and twist de pie → **14 Neuropatías de Cadera e Ingle**
- **PUDENDO** — Dolor perineal al sentarse o en bici, sin déficit sensitivo objetivo → **14 Neuropatías de Cadera e Ingle**
- **SENSIBILIZACIÓN CENTRAL** — Nada encaja o dolor extenso (revisar banderas rojas) → **15 Sensibilización Central**
- **NINGUNO** — Sin patrón neuropático ni dolor extenso → sin hipótesis

Leyenda

- Pregunta del árbol
- Hipótesis que activa la respuesta
- Derivación médica (el recorrido sigue)
- Sin hipótesis
- 📝 Formulario del paciente (G general, R región)

Al terminar sin ninguna hipótesis activa

La app propone trabajar con «dolor de cadera inespecífico», revisar los factores psicosociales (fase 1 y SINSS) y reconsiderar las respuestas. Si el cuadro es crónico y el riesgo psicosocial es alto, sugiere considerar también sensibilización central.

Fase 4b · confirmar

Cada hipótesis activa se confirma o descarta con sus tests: ver el esquema de confirmación de cadera.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0